

MULHERES NA PRAÇA, SAÚDE DE GRAÇA:

relato de experiência da equipe
multiprofissional do grupo de
mulheres do bairro tamarindo

ELIS SALES MUNIZ LIMA
ANA CESARINA SILVA GOMES
HYARA BRENA OLIVEIRA RUFINO
JAMILE XAVIER DE OLIVEIRA

 Editora
Hergel

Elis Sales Muniz Lima
Ana Cesarina Silva Gomes
Hyara Brena Oliveira Rufino
Jamilé Xavier de Oliveira

MULHERES NA PRAÇA, SAÚDE DE
GRAÇA: relato de experiência da equipe
multiprofissional do grupo de mulheres do
bairro Tamarindo

1ª Edição

Editora Hergel
2019

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Agência Brasileira do ISBN - Bibliotecária Priscila Pena Machado CRB-7/6971

L732 Lima, Elis Sales Muniz.

Mulheres na praça, saúde de graça : relato de experiência da equipe multiprofissional do grupo de mulheres do bairro Tamarindo [recurso eletrônico] / Elis Sales Muniz Lima ... [et al.]. — 1. ed. — Itajaí : Hergel, 2019.

Dados eletrônicos (pdf).

Inclui bibliografia.

ISBN 978-65-81566-01-2

1. Mulheres – Saúde e higiene. 2. Serviços de saúde para mulheres. 3. Mulheres – Saúde pública – Brasil. 4. Mulheres – Políticas de saúde. I. Título.

CDD 362.830981

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1.....	05
INTRODUÇÃO.....	06
 CAPÍTULO 2.....	 08
OBJETIVOS.....	09
 CAPÍTULO 3.....	 10
METODOLOGIA.....	11
 CAPÍTULO 4.....	 12
RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	13
 CAPÍTULO 5.....	 15
CONCLUSÃO.....	16
 REFERÊNCIAS.....	 17
 AUTORES.....	 19



CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

A Estratégia de Saúde da Família é modelo que se fundamenta nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) para a reorganização da Atenção Básica, através do trabalho da equipe mínima e da articulação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) em alguns territórios (BRASIL, 1997).

Para que a Atenção Básica possa cumprir sua missão na Rede de Atenção à Saúde, é necessário que a comunidade conheça os Centros de Saúde da Família que estão próximos ao seu bairro e, a partir daí, solucionar a maior parte dos problemas de saúde do território adstrito que chegam até o Centro de Saúde da Família (CSF).

Uma das características do CSF é ser considerada uma das “portas de entrada” do acesso ao SUS na atenção primária, junto aos serviços de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especial de acesso aberto (BRASIL, 2011). Então, inicia-se com o acolhimento até o atendimento e resolução do caso em questão ou encaminhamento para serviço especializado, minorando os danos e buscando integralidade do cuidado do usuário.

A demanda que se recebe na Unidade Básica de Saúde é

diferenciada pelo território, pela sazonalidade do clima e por fatores como idade e sexo.

De modo geral, as mulheres utilizam mais os serviços de saúde no Brasil, sejam por maior frequência de doenças de curta duração, por fatores genéticos, hormonais e, possivelmente, até culturais (PINHEIRO, 2002, p.688). Este último relaciona-se com o tempo que a mulher gasta com sua posição no mercado de trabalho, com o autocuidado que possui maior que o homem ou com outras motivações sociais.

Devido à grande demanda à saúde da mulher nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), é necessário reforçar as estratégias de cuidado e de acesso às informações para este público. Para isto, é importante que o percurso para esse alcance de educação em saúde para a população seja, em algumas situações, invertido. Ao invés da população procurar os profissionais para solucionar o seu problema de saúde, a equipe busca esse público no seu próprio território (casas, ruas, igrejas e outros locais de referência para o bairro) para realizar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.

Diante do exposto, iremos apresentar neste relato de experiência o cenário no qual

participamos no CSF do Bairro do Tamarino, na cidade de Sobral. Devido ao grande número de mulheres no posto de saúde referido- se a insatisfação pelo oferecimento de serviços voltado a este público foi possível em 2016 criar um grupo de mulheres. Este grupo era formado por profissionais da Estratégia de

Saúde da Família (ESF) (enfermeiros, agentes comunitários de saúde, dentista e etc), a equipe multiprofissional do NASF e alguns estagiários. Através deste trabalho, iremos relatar como se deu a criação do grupo, as dificuldades e os resultados com essa mobilização diferenciada.



CAPÍTULO 2

OBJETIVOS

OBJETIVOS

- Desenvolver ações de educação em saúde para público feminino local;
- Ofertar informações através de atividades lúdicas voltadas ao autocuidado;
- Contribuir para a qualidade de vida do público envolvido.

A close-up photograph of a person's eye, looking directly at the camera. The image is heavily stylized with a solid blue overlay that covers the entire frame. The eye's iris and pupil are visible through the blue tint. The text 'CAPÍTULO 3' is centered over the eye in a bold, yellow, sans-serif font.

CAPÍTULO 3

METODOLOGIA

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência onde o público alvo foi o grupo de Mulheres do Bairro Tamarindo, na Cidade de Sobral-Ce acompanhados pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipe Básica.

Os encontros do grupo aconteceram uma vez por semana, preferencialmente na terça-feira, na praça do bairro Tamarindo, na referida cidade. Alguns desses encontros foram realizados em locais escolhidos pelas próprias participantes do grupo, como na Associação de Moradores do bairro.

As atividades realizadas eram momentos lúdicos de educação em saúde, palestras sobre a Saúde da Mulher, e outros temas eram propostos de acordo com o interesse das participantes do

grupo, sendo determinados na reunião anterior por elas e pela equipe que compunha e cuidava do grupo.

Os profissionais utilizavam esse momento como forma de construção de convivência, elaboração de cronogramas dos encontros, realização de atividades e a reavaliação periódica dos assuntos e metodologias abordadas.

Os dados apresentados neste trabalho foram possíveis através da própria vivência autoral no grupo e provenientes da sistematização de diários, levantamento de mapas para atendimentos e prontuários, onde foram documentadas e registradas todas as atividades realizadas no grupo, durante a permanência da equipe do NASF.

CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do que foi apresentado neste trabalho, podemos perceber a importância da criação de um grupo específico na Unidade Básica de Saúde. É necessário, entender, a demanda que surge em cada Unidade e poder gerir ações que apoiem os processos de promoção de saúde e prevenção de doenças, além da cura e tratamento em alguns casos próprios da atenção primária.

O grupo de mulheres no bairro do Tamarindo alcançou o intuito de promover espaços de diálogo da equipe de saúde com o público feminino, ouvir as queixas e dúvidas da população e se apropriar do conceito de clínica ampliada na prática, ou seja, fazendo com que a saúde seja estendida para além das instituições tradicionais (Hospitais, UBS, etc.) e se apropriem, de fato, no cotidiano e nas casas dos usuários.

Foi possível também perceber a adesão das equipes de residência, equipe de referência e de NASF, como cuidadores do grupo, desempenhando o papel de integralidade do cuidado, já que as equipes eram compostas por diferentes categorias profissionais, como enfermeiros, assistentes sociais, educadores físico, farmacêutico, psicólogo,

agentes comunitários de saúde, dentistas e outros.

Com a realização destas ações diversos resultados positivos foram percebidos, tanto para as mulheres frequentadoras do grupo quanto para os profissionais de saúde envolvidos. Podemos citar como resultados dessa experiência a integralidade do cuidado com a equipe, o acesso à saúde pública através da inserção dos profissionais na comunidade, a territorialização e vivência da experiência com campo e a validação do movimento de clínica ampliada, ou seja, oferecer à população serviços de saúde que ultrapassem as paredes institucionais de centros de saúde da família, hospitais e etc. Desse modo, pode-se citar a ampliação do vínculo entre a população femininada bairro tamarindo com a equipe de saúde, por meio da troca de experiências e informações, se constituindo em uma ação de educação em saúde, que possibilita e promove sua inclusão social.

Além das ações em Saúde, o grupo torna-se para essas mulheres um espaço em que se pode falar sobre tudo, sem julgamentos e restrições.

Percebemos que conseguimos junto delas construir um lugar de fala e escuta, quando contam

sobre suas intimidades, as histórias de vidas carregadas sem medo de estar sendo fiscalizadas. Além disso, o grupo se constituiu em espaço de formação de vínculo comunitário.

Portanto, a vivência mostra que o desenvolvimento de atividades grupais é essencial ao processo de educação em saúde com a

população feminina. Dessa forma, apropriar-se do referencial teórico e metodológico de grupos é necessário para o desenvolvimento profissional, com vistas a constituir grupos consistentes, qualificados e resolutivos que estimulem a saúde e melhorem a qualidade de vida dessas mulheres.



CAPÍTULO 5

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos, percebe-se a importância da ESF (Estratégia de Saúde da Família) juntamente com o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e o apoio dos ACS (Agentes Comunitário de Saúde) em levar discussões básicas e fundamentais a população feminina, formando assim o Grupo de Convivência em saúde da mulher daquele determinado território.

A atuação da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, foi factível a relevância da visão diferenciada que os profissionais tiveram ao perceber junto com a comunidade e os

agentes comunitários de saúde a necessidade de levar discussões básicas e fundamentais sobre a saúde, que grande parte da população feminina desconhecia no território. O grupo possibilitou uma autonomia maior da população sobre os seus processos de adoecimento ou dúvidas que carregavam. A formação de criação de um grupo fora da UBS foi tanto quanto desafiador, recompensador, pois o aprendizado da comunidade e dos profissionais em relação aos novos métodos de trabalho mostraram que “fazer saúde” é algo de corresponsabilidade de todos.

A close-up photograph of a human eye, looking directly at the camera. The image is heavily blurred and has a strong blue color overlay, making the details of the eye and surrounding skin indistinct. The word "REFERÊNCIAS" is superimposed in the center in a bright yellow, bold, sans-serif font.

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde da Família**: uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial. Brasília, DF, 1997.
- [2] BRASIL. **Decreto nº 7508, de junho de 2011**. Brasília-DF, 2011.
- [3] PINHEIRO, R. S. *et al.* Gênero, morbidade, acesso e utilização de serviços de saúde no Brasil. **Ciênc. saúde coletiva**. Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p. 687-707, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232002000400007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 21 Mar. 2017. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232002000400007>.
- [4] BITTAR C; Lima LCV. O impacto das atividades em grupo como estratégia de promoção da saúde na senescência. **Rev. Kairós Geront**, 2011; 14(4): 101- 118.



AUTORES

Elis Sales Muniz Lima

Psicóloga graduada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em 2015; especialista em Saúde Pública e Saúde da Família pelo Centro Universitário UNINTA, em 2018, e mestranda do Programa de Pós-graduação em Saúde da Família (UFC). Atua como psicóloga clínica e como professora universitária da Faculdade Luciano Feijão, em Sobral-CE.

Ana Cesarina Silva Gomes

Graduada em Fisioterapia, pelo Centro Universitário UNINTA em 2015, Pós-graduanda em Saúde Pública e Saúde da Família. Atualmente atua como preceptora do Centro Universitário UNINTA.

Hyara Brena Oliveira Rufino

Fisioterapeuta Graduada pelo Centro Universitário Inta (Sobral-CE) no ano de 2015, Pós-Graduada em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família pelo UNINTA (Sobral-CE); Especialista em Fisioterapia Hospitalar pela Faculdade Inspirar Curitiba). Preceptora de Estágio Supervisionado UNINTA; Fisioterapeuta do Home Care Cariri.

Jamile Xavier de Oliveira

Fisioterapeuta graduada pelo Centro Universitário Inta (Sobral-CE) no ano de 2015, pós-graduanda em Saúde Pública e Saúde da Família pelo Centro Universitário UNINTA (Sobral-CE), Preceptora do Centro Universitário UNINTA (Sobral-CE). Graduanda do Curso de Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, membro do Grupo de Estudos de Afetividade e Participação - GEPAR.

